EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70608
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-09-11 12:32:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO FLORENCIO QUEZADA GODOY			RUN	: 6.109.150-5
F.Nac	: 01-12-1948	Edad	: 74 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: V MACKENNA 892			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-08-28	Fecha Egreso	: 2023-09-11 12:32:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J81.X-EDEMA PULMONAR.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia cardíaca congestiva clase funcional II de la NYHA.
2. Cardiopatía dilatada no isquémica con disfunción sistólica severa.
3. Fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular adecuada.
4. Hipertensión arterial estadio 2.
5. Insuficiencia renal crónica estadio IIIB.
6. Edema agudo de pulmón resuelto.
7. Neumonía intrahospitalaria resuelta.
8. Insuficiencia renal aguda prerrenal resuelta.
9. Anemia de trastorno crónico en resolución.
10. Trastorno deglutorio en rehabilitación.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J81-EDEMA PULMONAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I48.2-FIBRILACION AURICULAR CRONICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. J42.-BRONQUITIS CRONICA NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I11.0-ENF. CARDIACA HIPERTENCIVA CON INSUF. CARDÍACA (CONGESTIVA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Pedro Florencio Quezada Godoy, 74 años, masculino.

Motivo de ingreso:
Insuficiencia cardíaca aguda descompensada con edema agudo de pulmón.

Antecedentes:
Cardiopatía dilatada no isquémica con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Portador de DAI-CRT. Fibrilación auricular crónica. Hipertensión arterial. Insuficiencia renal crónica estadio IIIB.

Hospitalización:
Ingresó a UCI por edema agudo de pulmón que requirió intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Luego de manejo dirigido evolucionó favorablemente, logrando extubación a las 48 horas. Tuvo neuropatía posventilatoria con episodio aislado de estridor laríngeo, manejado sin reintubación. Desarrolló insuficiencia renal aguda prerrenal que revirtió con reposición de volumen y ajuste de diuréticos. Infección respiratoria tratada según cultivo. Presentó delirium hiperactivo controlado.

Condición al egreso:
Estabilizado. Eupneico sin requerimientos de oxígeno. Hemodinámicamente compensado. Ritmo sinusal. Función ventricular izquierda conservada respecto a basal. Función renal normalizada. Sin infección activa. Consciente y orientado. Con deglución en recuperación, pero aún con riesgo de aspiración, por lo que mantiene sonda nasogástrica.

INDICACIONES AL ALTA

1. - Hodom para rehabilitación deglutoria(fono)
2. - Control de función renal en 72 horas, crea, bun, elp, hemograma pcr
3. - Alimentación por sonda nasogástrica a con regimen papilla e hidratación por sng 1500 cc día al menos
4. - Regimen papilla hiposódico por boca asistido y segun tolerancia
5. - Furosemida 20 mg VO c/12h.
6. - FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 2 puff cada 12 horas
7. - Bisoprolol 2.5 mg VO c/12h.
8. - Enalapril 10 mg 1 cada 24 horas vo
9. - Espironolactona 25 mg VO c/24h.
10. - Dabigatrán 110 mg VO c/12h.
11. - Famotidina 40 mg VO c/24h.
12. - B ipratropio 2 puff c/6-8h según necesidad.
13. - Empaglifozina 10mg 1 al día
14. - Quetiapina 25 mg 1/2 comp vo solo en caso de insomnio
15. - Recuperar su hora en poli cardiologia (o en su defecto de medicina interna).

Control en: 14 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Félix Sanhueza Luna
MEDICO TRATANTE
14542245-0

JEFE SERVICIO